



Práticas de Redução de Danos

Práticas de RD têm origem em centros de saúde destinados a cuidar de pessoas em contexto de uso abusivo de álcool e outras drogas. Os primeiros registros específicos que temos advêm de países europeus, como Holanda, Inglaterra e Portugal. No Brasil, as primeiras experiências ocorreram no município de Santos, no final da década de 90, no período de intervenção no hospital Anchieta, conforme Domanico (2018).

As práticas surgiram a partir da necessidade de reduzir a contaminação de doenças infectocontagiosas, especialmente HIV/aids, as hepatites B e C. Ao se deparar com o avanço desses quadros e as vias de transmissão, ações de trocas de seringa foram organizadas, em que uma pessoa levava uma seringa usada a uma instituição de saúde e recebia uma nova. Embora tenha despertado resistências intensas de diversos grupos mais conservadores, a estratégia surtiu efeitos no que se propôs, reduzindo os índices de transmissão dos agravos por usuários de drogas injetáveis.

Essas práticas representam uma ruptura importante no modelo de atenção psicossocial para pessoas em contexto de uso de substâncias psicoativas. Tradicionalmente, as intervenções terapêuticas norteavam-se exclusivamente pelo princípio da abstinência do uso de todas as drogas. Aquelas pessoas que não queriam ou não conseguiam alcançar tais objetivos eram, por vezes, desligadas dos serviços, não podendo mais serem acompanhadas pelos profissionais. A RD, no entanto, inaugurou uma nova proposta, não somente objetivando a abstinência, mas a redução do uso e a redução dos danos associados a esses usos como possibilidades. Ou seja, o acolhimento e o cuidado, ainda que o sujeito mantivesse algum nível de relação com a droga.